

40 - 11-Les grands syndromes - Pr. L. Bendriss

Alors le cours d'aujourd'hui ça va être les grands syndromes. Comme je dis syndrome, c'est l'ensemble un petit peu de signes qui vont être regroupés, que ce soit des symptômes aléatoires, que ce soit des signes physiques, l'examen clinique, et puis on peut ajouter aussi des signes radiologiques et des signes électriques sur l'électrocardiogramme. Dans ce cours, on va essayer de définir les syndromes suivants, l'insuffisance cardiaque gauche, l'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance cardiaque globale, et l'hypertension artérielle-pivolière.

Tous les signes de ces quatre syndromes, on les a déjà vus, donc tous les cours précédents, on va juste un petit peu les regrouper pour chaque syndrome. Alors je commence par l'insuffisance cardiaque gauche, donc j'ai un problème d'un ventricule gauche et ou une oreillette gauche qui vont être insuffisants, c'est-à-dire le ventricule gauche aurait du mal à satisfaire les besoins de l'organisme en termes de débit cardiaque, donc j'aurai des cavités qui sont un petit peu déficientes. Et sur le plan clinique, ça va se manifester, si vous vous rappelez, la dyspnée d'effort avec toute la classification de la mya, et puis ça va évoluer vers la dyspnée de décubitus en orthopnée, et le stade ultime, c'est l'œdème aigu du poumon, qui est dû à l'inondation alvéolaire.

Alors le sub-œdème d'effort, c'est une forme atténuée de l'œdème aigu du poumon, et le pseudo-asthme cardiaque, c'est une autre forme d'inondation, mais cette fois-ci n'est pas alvéolaire, mais plutôt péribranchée, c'est-à-dire autour des branches souches et leurs divisions, et qui va se manifester comme un tableau d'asthme, c'est-à-dire un bradipnée expiratoire, une respiration sifflante, mais juste ça va mimer, mais c'est un asthme plutôt cardiaque, c'est la raison pour laquelle on l'appelle pseudo-asthme cardiaque. Alors ça, c'était les signes fonctionnels. Les signes physiques, c'est-à-dire l'examen clinique, à chaque fois que vous avez une insuffisance d'une cavité, vous aurez deux types de signes, vous aurez les signes au niveau de cette cavité, au niveau cardiaque, et les signes qui sont en amont, parce que vous aurez un retentissement plutôt en amont de cette cavité, ce qui est avant cette cavité.

Alors par rapport au cœur rouge, nous aurons des signes au niveau cardiaque, et ce qui est en amont, c'est la circulation pulmonaire, d'accord? Donc au niveau cardiaque, j'aurai un choc de pointe, soit qu'il est en place et bien petit fort, soit qu'il va être abaissé et dévié à gauche quand vous aurez une dilatation du ventricule rouge. Et puis j'aurai un soulèvement systolique infini du vélo-pulmonaire si vous vous rappelez qu'il se réduit à une hypertension artérielle pulmonaire. N'oubliez pas, c'est une pathologie qui peut vous donner ce qu'on appelle la stase vélo-pulmonaire capillaire, d'accord? C'est des choses qu'on a déjà vues.

Je pourrais avoir un tachycardie, c'est un cœur qui souffre. J'aurai des bruits de galop, B3 et BK, c'est quoi le galop? Alors pour définir ce que c'est que le galop, je dois définir ce que c'est que les bruits surajoutés. On va avoir deux bruits qui peuvent surajouter, B3 ou B4.

Alors B3, c'est un bruit protodiastolique et B4, c'est un bruit télédiastolique. Généralement, on ne

les entend pas en pratique courante. Quand vous avez une insuffisance cardiaque, on va créer ce qu'on appelle un galop.

Un galop, quand vous avez B1 et B2, avec ce bruit surajouté qui devient audible, et quand vous êtes dans une atmosphère de tachycardie, ça va créer comme un bruit de galop. Donc galop est égal, bruit surajouté, dans une atmosphère de tachycardie. Donc, soit j'aurai un galop présistorique, c'est le B4, et à chaque fois que vous avez un galop, ça traduit une diminution de la compliance du ventricule gauche parce qu'il est défaillant.

Donc la compliance, c'est un petit peu l'ampliation ou l'élasticité de ce ventricule. Donc, diminution de la compliance du ventricule gauche en télé-diastole va nous définir le galop télé-diastolique ou présistorique. Et puis quand cette compliance est diminuée à la fin de la protodiastole, j'aurai un galop protodiastolique et qui va être de pronostic ou beaucoup plus grave.

Je pourrais avoir à l'auscultation aussi une insuffisance mitrale fonctionnelle, non pas parce que les valves sont malades, mais vous avez un ventricule gauche qui est dilaté avec l'anneau qui va être dilaté. Vous aurez un défaut de coaptation des valves mitrales au cours de la systole et du coup vous aurez une insuffisance mitrale fonctionnelle avec un souffle holocystolique et radiation axillaire d'intensité modérée. Et puis comme autre élément à l'auscultation, l'éclat de B2 au foyer pulmonaire qui va traduire l'hypertension artérielle pulmonaire.

Vous aurez un deuxième bruit B2 au niveau du foyer pulmonaire qui va être claqué. Vous allez mieux l'entendre par rapport à B1, c'est ce qu'on appelle éclat de B2. Alors, au niveau cardiaque, je vous ai dit la circulation en amont, c'est la circulation pulmonaire.

Vous aurez un petit peu toutes les choses dont on vient de parler sur la radiographie thoracique qui sont les signes de stage vélo-pulmonaire capillaire. Alors, à la palpation, je pourrais avoir une diminution des vibrations vocales qui peut me faire penser à un épongement pleural, à la percussion en matiété des basses, toujours donc un épongement pleural, et à l'auscultation, une diminution des murmures vésiculaires dues surtout aux épongements pleuraux et aux râles crépitants, si vous vous rappelez les râles crépitants qui sont présents dans l'œdème aigu du poumon quand vous êtes au stade ultime. À la radiographie thoracique, vous aurez les stades radiologiques qu'on vient de faire en radiologie.

Stade 1, soit une redistribution vasculaire des sommets. Stade 2, c'est l'interstitiel. Et stade 3, c'est les images d'œdème aigu du poumon qui sont des opacités périphilières malimitées, confluentes, floconneuses et en ailes de papillons.

Ça, c'est les scènes radiologiques sur le plan vascularisation pulmonaire. Quand on regarde les scènes radiologiques par rapport à la silhouette en elle-même, on peut trouver une silhouette qui est dilatée, c'est-à-dire un quart du mégalith, vu que c'est une instance cardiaque. Vous aurez un arc inférieur rouge allongé avec une pointe qui plonge sous le diaphragme.

Je vous ai parlé de l'hypertension artérielle pulmonaire, donc l'arc moyen-gauche qui va être plutôt convexe et qui va témoigner un peu de l'hypertension artérielle pulmonaire suite à ces phases vénopulmonaires capillaires. Et puis, je pourrai avoir un débord droit et double contour de l'arc inférieur droit qui va nous faire penser à une dilatation de l'oreillette gauche. N'oubliez pas, c'est une instance cardiaque gauche qui va intéresser le ventricule gauche et l'oreillette gauche.

Alors, sur l'électrocardiogramme, en matière d'insuffisance cardiaque gauche, vous allez avoir soit des signes de la cardiopathie causale et ou sans retentissement. Donc, j'aurai l'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, une chose que j'ai voulu vous signaler, c'est que quand on parle d'hypertrophie sur l'électrocardiogramme, ça veut dire les deux.

Ça veut dire l'hypertrophie ou la dilatation d'une cavité. Quand je dis hypertrophie, cela veut dire que vous avez l'augmentation de la masse, ça veut dire myocardique, et quand je parle de dilatation, c'est l'augmentation de la cavité cardiaque. Donc, le terme hypertrophie sur l'électrocardiogramme peut dire l'une des deux.

Ça veut dire soit l'hypertrophie, soit la dilatation. Donc, j'ai une hypertrophie ventriculaire gauche, j'aurai une hypertrophie auriculaire gauche, un bloc de branche gauche est aussi possible, et un trouble uride peut être noté, n'importe quel. L'insuffisance cardiaque droite, cette fois-ci, au lieu de la dyspnée qui répondait à la classification de l'amias, j'aurai les hépatalgies, les douleurs au niveau du foie, d'abord d'effort, et puis de repos.

Puis la dyspnée, généralement, elle n'est pas là, sauf si vous avez une affection, notamment une atteinte pulmonaire qui aurait pu causer une insuffisance cardiaque droite, et généralement, vous n'avez pas d'orthopox. Alors, les signes physiques, toujours les signes cardiaques, et les signes de la circulation en amont. Alors, ce que vous avez en amont, c'est le réseau veineux profond, ou les signes veineux systémiques.

D'accord? Alors, les signes cardiaques, toujours, je vais avoir le soulèvement cytonique infundique pulmonaire, qui serait dû, cette fois-ci, à une hypertension pulmonaire, mais pas postcapillaire, parce que la postcapillaire est due à l'insuffisance cardiaque gauche, mais cette fois-ci, précapillaire, avant les capillaires, qui serait dû probablement à l'augmentation des résistances pulmonaires ou autres. Le signe de Harzer positif, qui va témoigner de l'hypertrophie ventriculaire droite. N'oubliez pas que vous avez une hypertension pulmonaire, vous aurez l'augmentation de la poste de charge du ventricule droit, et qui va retentir sur la cavité en amont par une hypertrophie.

Le galon, même cette fois-ci droit, même signification par rapport au galon de tout à l'heure. L'insuffisance tricuspidiennne, qui serait due à une dilatation de l'anneau tricuspide, parce que vous avez une dilatation du ventricule droit, parce qu'il est défaillant. Et puis, j'aurais l'éclat de B2, d'accord, quand il y a une hypertension artérielle pulmonaire.

Les signes périphériques, c'est les signes veineux systémiques. J'aurai une turgescence pantalée des veines jugulaires externes. J'aurai une hépatomégalie, quand vous allez la palper, il est douloureux, c'est une fois qui est douloureux, caractéristique du froid cardiaque.

Vous aurez le reflux hépatojugulaire, on l'a vu dans l'examen clinique. Je pourrais avoir l'acide et les œdèmes des rangs inférieurs, qui sont blancs, mou, prenant le godet, et qui sont déclivants. Sur la radiographie thoracique, vous aurez une dilatation des artères pulmonaires.

Donc, n'oubliez pas que c'est des artères pulmonaires. Je pourrais avoir une hypertension artérielle pulmonaire avec une dilatation. Et quand j'ai une quantation de résistance sur les artères pulmonaires, du coup, la vascularisation pulmonaire en périphérie va être diminuée, d'accord, contrairement à l'insuffisance cardiaque rouge.

Et la silhouette cardiaque va dépendre de la cause ou de la conséquence. Alors, vous avez de l'insuffisance cardiaque droite, vous aurez une pointe qui va être susdiaphragmatique et un dévirement droit de l'arc inférieur droit, qui serait dû à une dilatation de l'oreillette droite. Et sur l'électrocardiogramme, c'est des signes droits, soit une hypertrophie auriculaire droite, et quand je dis hypertrophie sur le CGCL2, soit l'hypertrophie, soit la dilatation.

Même chose, hypertrophie ventriculaire droite, un bloc de branche droit, et un trouble du rythme est toujours possible. L'insuffisance cardiaque globale, c'est quand vous summez les deux, l'insuffisance cardiaque gauche et l'insuffisance cardiaque droite, et le syndrome d'hypertension artérielle pulmonaire, qui pourrait exister, que ce soit dans l'insuffisance cardiaque gauche ou dans l'insuffisance cardiaque droite, ou tout court pour une autre pathologie, parce que ça peut caractériser autre chose. Donc, il va se manifester par une dyspnée, un soulèvement systolique infundible pulmonaire.

Donc, je somme un petit peu les signes d'hypertension artérielle pulmonaire, l'éclat de B2 pulmonaire. Sur la radio, vous aurez l'arc moyen gauche qui va être soit rectiligne ou convexe, qui va témoigner un petit peu de dilatation de l'artère pulmonaire. Et sur l'ECG, vous aurez une hypertrophie ventriculaire droite.

Pourquoi ? Parce que vous avez l'augmentation de la pousse de charge du ventricule droit et qui va retentir sur la cavité d'avant qui va s'hypertrophier. Et je vous remercie.